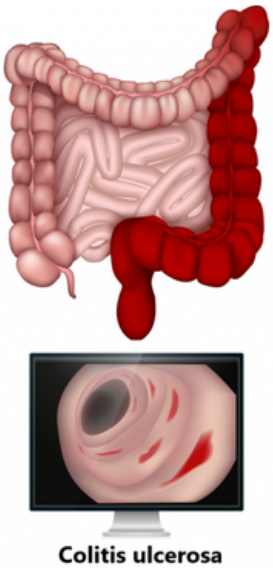
ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL

DR. EDGARDO ARCIA

COLITIS ULCERATIVA: PATRÓN CURATIVO

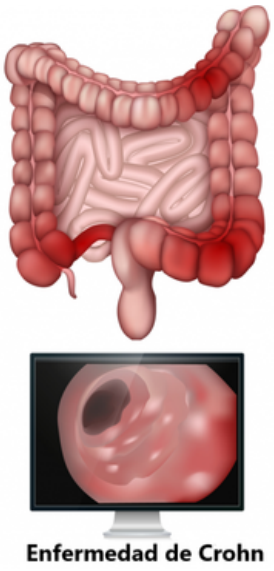
- Afectación continua de la mucosa/submucosa, inicia en el recto y se extiende proximalmente sin áreas sanas intermedias.
- Cirugía electiva (curativa): panproctocolectomía restauradora con reservorio ileoanal en J (IPAA); preserva el aparato esfinteriano.
- Cirugía urgente (megacolon tóxico, hemorragia, perforación): colectomía total con ileostomía terminal (Hartmann rectal); se difiere el reservorio.



Colitis ulcerosa

ENFERMEDAD DE CROHN: MANEJO NO CURATIVO

- Afectación transmural, segmentaria y discontinua ("lesiones en salto"), puede afectar cualquier tramo digestivo, con predominio ileocecal.
- La cirugía NO es curativa; se reserva para falla del tratamiento médico o complicaciones (estenosis sintomáticas, fístulas, abscesos no drenables, perforación libre).
- Principio "Crohnservador": preservar la longitud intestinal para evitar el síndrome de intestino corto.



Enfermedad de Crohn

RESERVORITIS

- La complicación no quirúrgica más frecuente del reservorio ileoanal: aumento de deposiciones, tenesmo, dolor pélvico y rectorragia.
- Tratamiento: ciprofloxacino 500mg c/12h o metronidazol oral por 14 días. En casos crónicos descartar Crohn del reservorio o CMV.

SÍNDROME DE INTESTINO CORTO

- Complicación de resecciones extensas repetidas en Crohn; malabsorción severa que puede requerir nutrición parenteral domiciliaria permanente.

TÉCNICAS AHORRADORAS DE INTESTINO

- Resecciones segmentarias limitadas con márgenes ajustados a la enfermedad macroscópica.
- Estricturoplastias: restituyen el calibre luminal en estenosis fibrosas SIN resecar tejido intestinal.

COLITIS INDETERMINADA

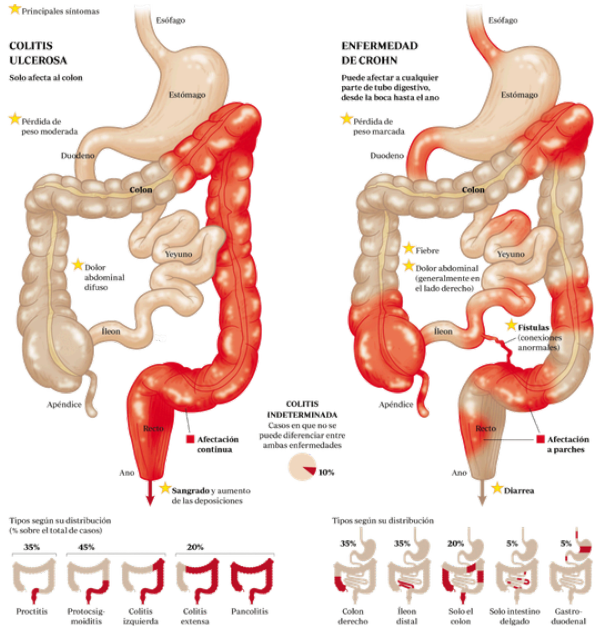
- 10-15% de los casos no pueden clasificarse con certeza entre CU y Crohn al diagnóstico; la decisión quirúrgica (IPAA vs resecciones segmentarias) se vuelve más compleja y se reevalúa con el tiempo.

ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL

DR. EDGARDO ARCIA

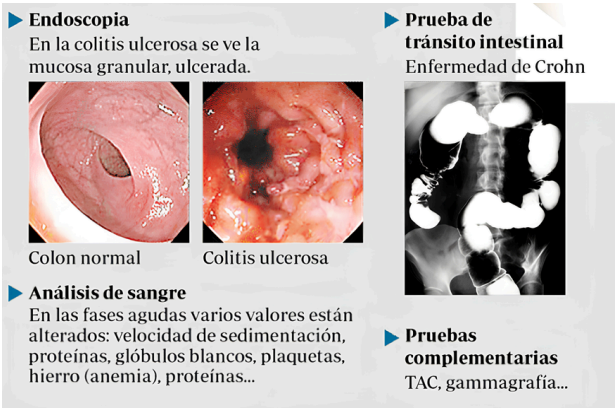
CROHN VS. COLITIS ULCEROSA

- Crohn: de boca a ano (más en íleon terminal), lesiones salteadas, transmural, granulomas no caseificantes, fístulas y estenosis; el tabaco lo empeora.
- CU: recto con extensión proximal continua, solo mucosa, abscesos crípticos y pseudopólipos; diarrea con sangre; el tabaco "protege".



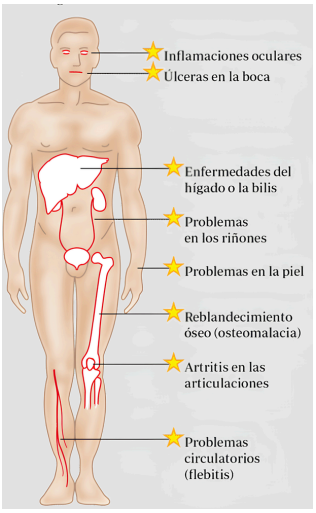
DIAGNÓSTICO

- Ileocolonoscopia con biopsias (de elección); calprotectina fecal para valorar actividad.
- Serología: p-ANCA (+) en CU, ASCA (+) en Crohn. Entero-RM o entero-TC para intestino delgado; descartar infección (C. difficile, CMV).



MANIFESTACIONES EXTRAINTESTINALES

- Siguen la actividad: artritis periférica, eritema nudoso, epiescleritis y aftas orales.
- Independientes: espondilitis anquilosante, uveítis y colangitis esclerosante primaria (más en CU); pioderma gangrenoso, variable.



TRATAMIENTO MÉDICO ESCALONADO

- Inducción: 5-ASA (CU leve-moderada) y corticoides en brotes (nunca de mantenimiento; budesonida en Crohn ileal).
- Mantenimiento: 5-ASA (CU), azatioprina/6-MP, metotrexato (Crohn) y biológicos: anti-TNF (infliximab, adalimumab), vedolizumab, ustekinumab.

MEGACOLON TÓXICO

- Colon transverso >6 cm + toxicidad sistémica; más en CU. Evitar opioides, anticolinérgicos y colonoscopia.
- Reposo digestivo, SNG, corticoides IV y antibióticos; sin mejoría en 24–72 h o perforación: colectomía subtotal con ileostomía.

RIESGO DE CÁNCER Y VIGILANCIA

- Aumenta con la extensión (pancolitis), la duración (>8–10 años) y la colangitis esclerosante primaria.
- Colonoscopia de vigilancia desde los 8 años del diagnóstico, cada 1–3 años (anual si hay CEP). Displasia de alto grado o cáncer → proctocolectomía.

ENFERMEDAD PERIANAL EN CROHN

- Fístulas complejas, abscesos y fisuras atípicas (laterales o múltiples).
- Drenaje del absceso + setón laxo, antibióticos (metronidazol/ciprofloxacino) y anti-TNF; evitar la fistulotomía en fístulas complejas.

SEVERIDAD (TRUELOVE-WITTS)

- Brote grave de CU: ≥6 deposiciones con sangre al día + ≥1 de: FC >90, T >37,8 °C, Hb <10,5 g/dL o VSG >30 mm/h.
- Hospitalizar y dar corticoides IV; sin respuesta en 3–5 días: infliximab, ciclosporina o colectomía.